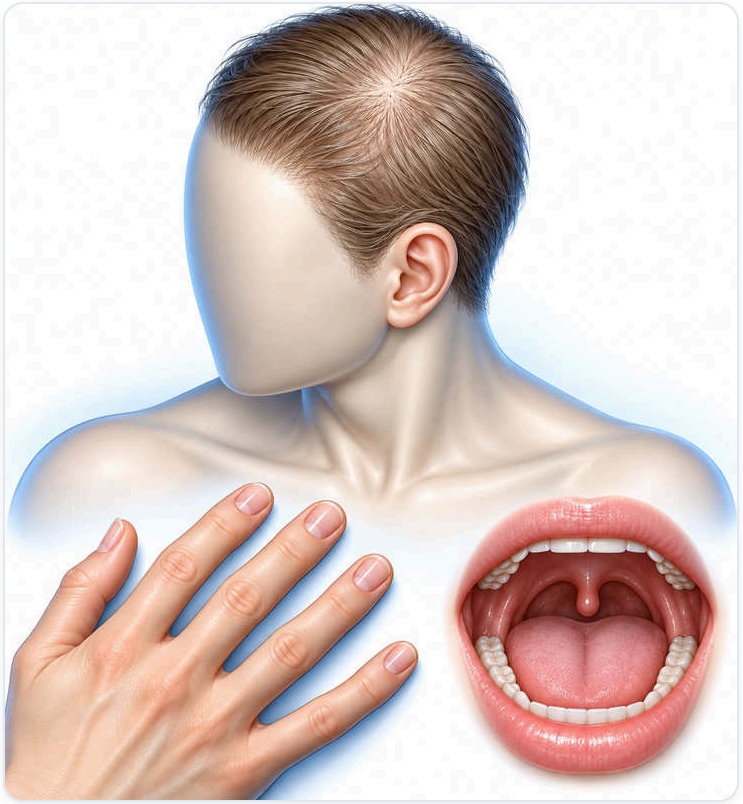
루푸스와 피부근염 피부에서 전신으로

피부로 먼저 보이는 루푸스와 피부근염: 장기 침범·암 평가 연결

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

형태와 분포를 먼저 기록한다

피부는 전신 질환을 의심하게 하는 첫 단서가 된다



원발진의 형태

색 변화인 반점·반, 융기한 구진·판, 수포·농포·팽진 등을 구분해 기술한다.

분포와 배열

대칭·편측, 일광 노출부, 손 관절·폄측·눈꺼풀·몸통 등 위치를 확인한다.

발생 경과·병력

발병일·기간·재발, 피부 외 증상과 약물 복용력, 여행·환경·계절·가족력을 묻는다.

전신 피부 진찰

두피·귀·손발톱·구강 등도 함께 살핀다. 형태학적 분류와 분포가 진단의 출발점이다.

피부 소견을 정확히 기술한 뒤 루푸스·피부근염의 특이 징후와 연결한다.

루푸스는 피부 아형과 전신 활동성을 잇는다

급성·아급성·만성 피부홍반루푸스를 구분한다

급성 · ACLE

대부분 전신형의 급성 악화기에 나타난다. 나비모양발진이 대표다.

아급성 · SCLE

항 Ro/SS-A 항체가 흔하고 구진비늘 또는 고리모양 병변. 약 50%가 전신형 기준을 충족한다고 설명했다.

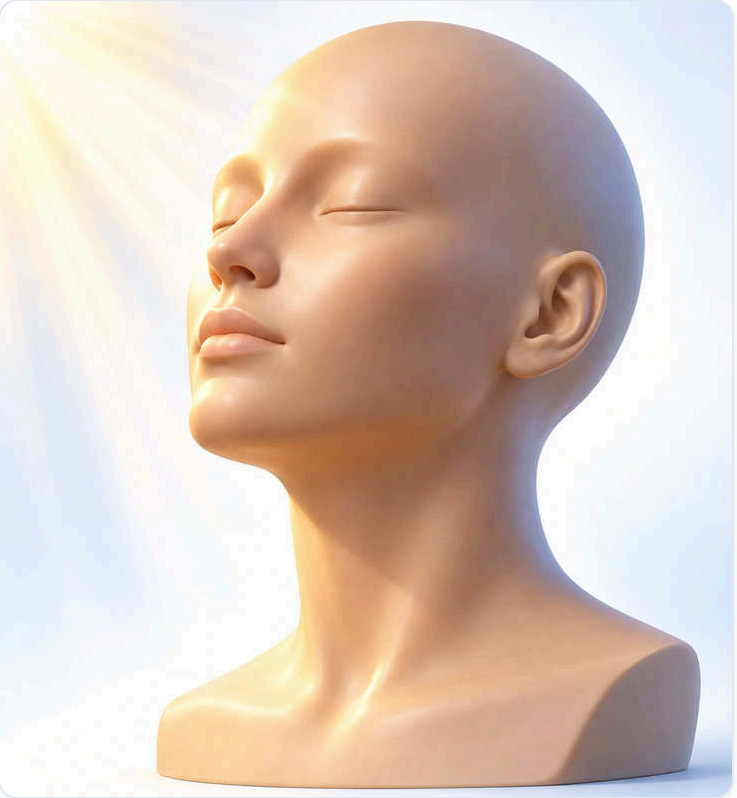
만성 · CCLE

원반모양홍반루푸스가 대표다. 전신형이 없거나 경미할 때 흔한 피부 아형으로 설명했다.

> 피부 아형이 다르면 전신 활동성과의 관계도 달라진다는 것이 강의의 핵심이다.

급성 피부 루푸스: 나비모양발진

콧등·양 볼·비구순주름·자외선의 관계



형태와 분포

콧등과 양 볼에 대칭적 홍반이 나타난다. 비구순주름은 침범하지 않는 것이 특징으로 제시되었다.

유발·악화

자외선 노출로 유발되거나 악화될 수 있다. 일광 노출과 피부 변화의 관계를 묻는다.

전신형의 맥락

강의는 급성 피부홍반루푸스가 전신형 급성 악화기에 흔하다고 설명했다. 얼굴 발진을 피부의 국소 문제로만 해석하지 않는다.

형태·분포·광과민성을 함께 묻는 것이 피부 아형을 구분하는 단서다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

아급성 피부 루푸스: 고리와 구진비늘

일광 노출부의 대칭 발진과 anti-Ro/SS-A 연관성

피부 양상

과각화성 구진비늘 또는 고리모양·다륜 판상 병변. 일광 노출부에 호발하고 흉터 없이 치유되는 양상을 교재에서 설명했다.

전신형과 연결

항 Ro/SS-A 항체가 흔하고 약 절반이 전신형 기준을 충족한다. 급성형과 만성형 사이의 전신 연관성을 가진 아형으로 설명되었다.

고리모양이라는 형태만으로 단정하지 않고 일광 노출·분포·각질 양상을 함께 평가한다.

만성 피부 루푸스는 흉터를 남길 수 있다

원반모양홍반루푸스(DLE)의 진행 소견

1

경계가 분명한 판

홍반성 판상 병변이 대표적 형태다.

2

비늘·모낭마개

병변 표면의 비늘과 모낭마개를 살핀다.

3

진행 후 변화

중심부 위축과 흉터성 탈모가 남을 수 있다.

4

전신 활동성 맥락

만성형은 전신형이 없거나 경미한 경우에 흔하다고 강의에서 설명했다.

비늘이 있는 판의 모습뿐 아니라 위축·탈모·흉터의 경과까지 기록한다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

비특이 피부 소견도 활동성의 단서

루푸스 특이 발진과 나란히 살핀다

혈관염성 자색반

혈관염과 관련된 자색반을 질병 활동성과 연결해 살핀다.

망상청피반

그물 모양으로 보이는 색 변화를 비특이 피부 증상으로 설명했다.

탈모·손톱주위 변화

탈모와 조갑주위 모세혈관확장이 교재의 비특이 소견에 포함되었다.

레이노 현상

레이노 현상도 루푸스의 비특이 피부 증상 및 활동성의 단서로 제시되었다.

피부 아형의 형태와 비특이 소견을 함께 보고 전신 상태와 연결한다.

피부근염의 두 가지 병태특이 소견

Gottron 구진과 Heliotrope rash

Gottron 구진·징후

손가락 관절 위의 각질을 동반한 보라색 구진이 Gottron 구진이다. 손 관절·팔꿈치·무릎·발목 폄측의 대칭 보라색 홍반은 Gottron 징후로 설명했다.

연자색 발진

Heliotrope rash: 눈둘레근 염증으로 윗눈꺼풀이 붓고 보라색으로 변하는 소견. Gottron 구진과 함께 진단적 가치가 가장 높은 두 징후다.

관절 위·폄측·윗눈꺼풀이라는 분포를 피부 형태와 함께 기억한다.

몸통·사지의 분포를 지도처럼 본다

피부근염의 기타 특징적 소견



피부근염의 분포

V sign

앞가슴·목의 자색 홍반.

Shawl sign

뒷목과 등 윗부분의 분포.

Holster sign

허벅지 측면의 분포.

기계공의 손

손가락 피부가 거칠어지는 소견으로 간질성 폐질환과의 연관성이 제시되었다.

손톱주위·피부 변화

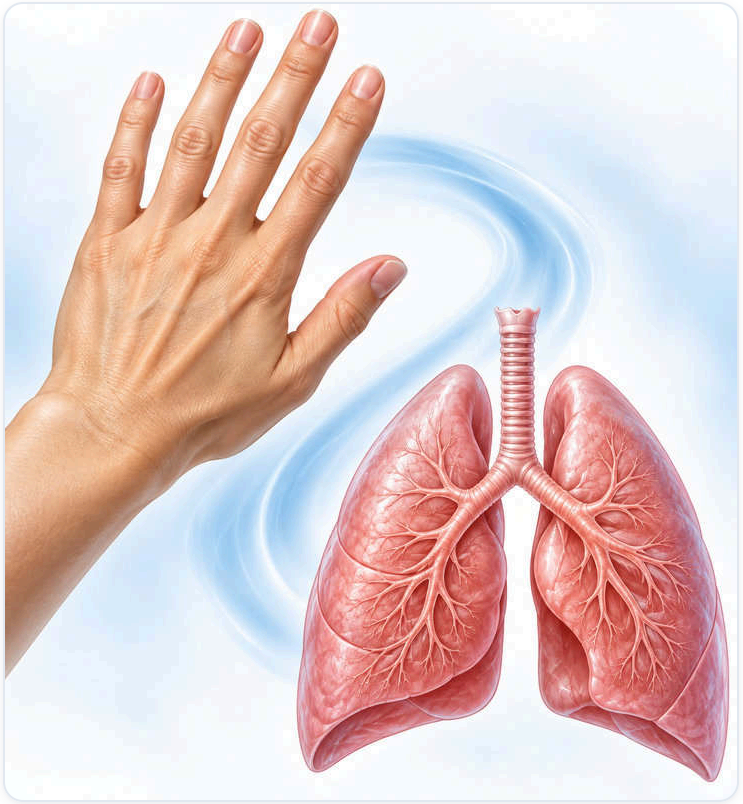
조갑주위 모세혈관확장과 다형피부증이 기타 특징적 소견에 포함되었다.

이 징후들은 서로 다른 부위에서 같은 피부근염의 단서를 제공한다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

기계공의 손을 폐 침범과 연결한다

손 피부의 특징적 변화에서 전신 평가로



피부 소견 확인

기계공의 손처럼 손가락 피부가 거칠어진 소견을 확인한다.

다른 피부근염 징후

Gottron 구진, 연자색 발진, V·Shawl·Holster 징후와 함께 해석한다.

장기 연관성

강의에서 기계공의 손은 간질성 폐질환과 연관된다고 설명했다. 피부 징후를 전신 질환 평가의 단서로 연결한다.

이 강의에서 제시한 피부–장기 연결의 핵심은 기계공의 손과 간질성 폐질환이다.

성인 피부근염은 악성종양 평가와 연결

강의에서 제시한 위험의 크기와 시간 창

10~20%

성인 피부근염 환자에서 악성종양이 동반되는 비율로 제시되었다.

발병 1~2년 내

악성종양이 주로 동반되는 시기로 강의에서 설명했다.

일반인의 4~6배

동반 위험이 높아 진단 시 나이에 맞는 악성종양 선별검사가 필요하다고 설명했다.

교재에 열거된 암: 유방·폐·난소·전립샘·대장·비인두암.

연자 Q&A: 양측 동전·고리 발진의 감별

형태 하나보다 가려움·각질·중심부·노출부를 함께 본다

화폐상습진

양측 팔다리에 여러 동전모양 병변, 가려움·건조·병변 전체의 홍반과 각질·진물·딱지면 우선 고려한다고 답했다.

체부백선

가장자리에 홍반·각질이 더 뚜렷하고 중심이 옅어지며 바깥으로 커지는 고리면 고려한다. 스테로이드 연고만 사용하면 변형·악화될 수 있다고 답했다.

건선

경계 명확한 붉은 판과 두꺼운 각질, 팔꿈치·무릎·두피의 병변을 함께 본다고 답했다.

아급성 피부 루푸스

일광 노출부의 대칭 고리 발진이 햇빛에 악화되면 감별한다. 비전형적이거나 치료 반응이 없으면 피부과 진료를 권한다고 답했다.

양측성·동전모양이라는 두 특징만으로 진단하지 않는다 — 연자 Q&A.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

피부의 형태·분포에서 전신 연결로

루푸스와 피부근염의 학습 포인트

루푸스

급성·아급성·만성 피부 아형을 구분하고 전신 활동성과의 관계를 본다. 일광 노출, 흉터·탈모, 비특이 혈관성 소견을 함께 기록한다.

피부근염

Gottron 구진·Heliotrope rash를 먼저 인지하고 V·Shawl·Holster 징후, 기계공의 손·조갑주위 변화를 살핀다.

장기·암 평가 연결

기계공의 손–간질성 폐질환 연관성과 성인 피부근염의 악성종양 동반 위험을 연결한다. 진단 시 연령에 맞는 암 선별을 시행한다는 강의 설명이다.

고리발진의 감별은 연자 Q&A의 형태·분포 단서로 넓혀 본다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

강의의 핵심을 진료의 연결점으로

피부로 먼저 보이는 루푸스와 피부근염: 장기 침범·암 평가 연결

루푸스

급성·아급성·만성 피부 아형을 구분하고 전신 활동성과의 관계를 본다. 일광 노출, 흉터·탈모, 비특이 혈관성 소견을 함께 기록한다.

피부근염

Gottron 구진·Heliotrope rash를 먼저 인지하고 V·Shawl·Holster 징후, 기계공의 손·조갑주위 변화를 살핀다.

광교바른내과

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

평일 08:30~18:30 · 토 08:30~13:30

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298,

4층 402-404호

031-893-4560

강의 학습자료 다시 보기

고리발진의 감별은 연자 Q&A의 형태·분포 단서로 넓혀 본다.